

HSC | GLOBAL

MDSAP LEAD AUDITOR • EXCELLENCE & STRATEGIC LEADERSHIP

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 3

Requisitos por jurisdição

Texto de estudo para acompanhar e revisar o módulo ao vivo

MÓDULO	3 de 6, ao vivo, em duas partes
CARGA	8h
DOCUMENTO BASE	MDSAP AU P0002.011, revisão de 03/08/2026
NORMAS NACIONAIS	Vigência conferida nos sites oficiais em 22/09/2026
INSTRUTORA	Mariana Barreira

MDSAP
MEDICAL DEVICE SINGLE AUDIT PROGRAM

EXEMPLAR GLOBAL
RTP CERTIFIED TRAINING

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue a mesma sequência das aulas do Módulo 3, bloco a bloco, mas não repete os slides. Ela organiza os requisitos de cada país pelo ponto de vista do auditor e aponta onde cada um está escrito no P0002.011 e na norma nacional.

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica o bloco e os slides correspondentes, o exercício do caderno e o que observar enquanto assiste. Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> **REGRA DE OURO DO CURSO**
>
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original pelo link e confira a revisão antes de usar.

•	Mapa do módulo: aula, apostila e caderno	3
1	Onde está o requisito de cada país	4
2	Brasil: Anvisa no MDSAP	7
3	Estados Unidos: FDA no MDSAP	10
4	Canadá: Health Canada no MDSAP	13
5	Austrália: TGA no MDSAP	16
6	Japão: MHLW e PMDA no MDSAP	19
7	Cinco jurisdições, um evento	22
8	Glossário	25
9	Para revisar	26

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e caderno

O Módulo 3 tem duas partes ao vivo e sete blocos: uma visão geral, um bloco para cada uma das cinco jurisdições e uma integração final. A Parte 1 fecha no slide 42 com a síntese de Brasil e Estados Unidos.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NESTA APOSTILA	NO CADERNO
1	Visão geral das cinco jurisdições	Parte 1, slides 4 a 12	Capítulo 1	E1, E2 e E3
2	Brasil: Anvisa	Parte 1, slides 13 a 27	Capítulo 2	E4, E5 e E6
3	Estados Unidos: FDA	Parte 1, slides 28 a 41	Capítulo 3	E7, E8 e E9
4	Canadá: Health Canada	Parte 2, slides 3 a 14	Capítulo 4	E10, E11 e E12
5	Austrália: TGA	Parte 2, slides 15 a 26	Capítulo 5	E13 e E14
6	Japão: MHLW e PMDA	Parte 2, slides 27 a 36	Capítulo 6	E15 e E17
7	Integração e avaliação	Parte 2, slides 37 a 40	Capítulo 7	E16 e avaliação final

Sua rotina em cada bloco

1 • PREPARE

O guia de preparação

Antes da Parte 1, faça o Guia de Preparação do aluno, com o P0002.011 aberto. Ele mostra onde procurar cada país.

2 • PARTICIPE

O bloco ao vivo

Acompanhe com o documento aberto na página citada. Anote dúvidas na página de anotações do capítulo.

3 • PRATIQUE

O exercício do caderno

Depois de cada bloco, leia o capítulo e resolva os exercícios indicados antes da discussão em sala.

ANTES DO MÓDULO 4

O Módulo 4 trata de graduação de não conformidade e relatório, a partir dos achados dos estudos de caso deste módulo. Chegue com os capítulos lidos e o Caderno de Exercícios do Módulo 3 feito.

CAPÍTULO 1

Onde está o requisito de cada país

NA AULA **Parte 1 • Bloco 1 • slides 4 a 12** **Caderno • E1, E2 e E3**

Observe os três pontos do documento base em que um requisito de país aparece e como o papel regulatório muda o que se cobra do auditado.

No Módulo 2 você percorreu as tarefas pela ISO 13485:2016. Agora entra a camada que cada autoridade coloca por cima dela: prazos, autorizações e comunicações próprias. Antes de estudar país por país, você precisa saber onde essa camada está escrita e para quem ela vale.

JURISDIÇÃO	AUTORIDADE	TEXTO DE SISTEMA DA QUALIDADE
Austrália	TGA	TG(MD)R 2002, Schedule 3
Brasil	Anvisa	RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação)
Canadá	Health Canada	SOR/98-282 (CMDR)
Japão	MHLW/PMDA	MO169 (QMS Ordinance)
Estados Unidos	FDA	21 CFR 820 (QMSR)

Três lugares para procurar

- **Campo Clause and Regulation.** Ao lado da cláusula da ISO, cada tarefa lista a referência de cada autoridade que tem algo a dizer sobre aquele tema.
- **Bloco Additional country-specific requirements.** É onde ficam os acréscimos práticos: prazos, comunicações, conteúdo mínimo de registros. Quando o bloco diz "None", o país nada acrescenta naquela tarefa.
- **Anexos.** O Anexo 1 trata de documentação técnica, o 3 de prazos de notificação, o 4 da correspondência entre a ISO e o MO169 e o 5 das exclusões de escopo.

> **CUIDADO COM A CONTAGEM**
>
> Japão e Brasil aparecem em dezenas de tarefas, porque seus textos acompanham a ISO artigo por artigo. Estados Unidos e Canadá aparecem em poucas, mas guardam boa parte das exigências nos blocos de país dos Capítulos 2 (autorização de mercado) e 4 (notificações). Quem lê só o campo de cláusulas deixa de ver prazos.

CAPÍTULO 1 (CONTINUAÇÃO)

Onde está o requisito de cada país

De quem é a obrigação

Cada país atribui a autorização de mercado a uma figura diferente: no Brasil, o fabricante nacional ou o importador que o representa; nos Estados Unidos, o titular da 510(k) ou da PMA; no Canadá, o fabricante titular da licença; na Austrália, o sponsor; no Japão, o MAH. Isso tem efeito direto no seu trabalho. Uma obrigação que o regulador impõe a outra pessoa não é cobrada do fabricante auditado. Ela só passa a ser auditável se o fabricante a assume por acordo, como requisito de cliente.

PERGUNTA DE ABERTURA

Antes de registrar qualquer não atendimento a requisito de país, pergunte: esta obrigação é de quem estou auditando?

Quando o texto do país mudou

O P0002.011 é o documento de trabalho, mas as normas nacionais continuam mudando depois de cada revisão dele. Quando a norma vigente diverge do que o documento reproduz, o auditor cita a norma vigente. Você vai encontrar exemplos disso no Canadá e nos Estados Unidos. A situação das normas usadas neste módulo foi conferida nos sites oficiais em 22/09/2026.

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Overview (p. 6, 7 e 10 a 12) e Anexos 1, 3, 4 e 5 (p. 143 a 162); ISO 13485:2016, 3.10, Nota 1. Contagem de citações: levantamento HSC.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Onde está o requisito de cada país

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

Brasil: Anvisa no MDSAP

NA AULA **Parte 1 • Bloco 2 • slides 13 a 27** **Caderno • E4, E5 e E6**

Observe como a aula usa a estrutura da ISO que você já conhece para chegar aos artigos da RDC 665/2022.

A RDC 665/2022 não menciona a ISO 13485. Quem liga uma à outra é o P0002.011, que põe o artigo da RDC ao lado da cláusula em quase todas as tarefas. Assim você audita o Brasil a partir do mapa que já domina.

ASSUNTO	TEXTO BRASILEIRO	ONDE PESA NO P0002.011
Boas Práticas de Fabricação	RDC 665/2022	Quase todas as tarefas
Requisitos essenciais	RDC 848/2024 (revogou a RDC 546/2021)	Capítulo 5, projeto
Regularização e alterações	Lei 6.360/1976, RDC 751/2022, RDC 830/2023	Capítulo 2
Tecnovigilância e ação de campo	RDC 67/2009, RDC 551/2021	Capítulo 4

As RDC 67/2009 e 551/2021 seguem vigentes, mas estão em revisão pela Anvisa desde 06/2026: confirme o texto em vigor no dia da auditoria.

O que a RDC pede além da ISO

Os blocos Brazil (ANVISA) trazem detalhes concretos que você pode pedir como evidência: lista mestra dos documentos vigentes e cópia de segurança dos registros eletrônicos (Arts. 33 e 35); consultores qualificados e controlados como fornecedores (Arts. 16 e 17); conteúdo mínimo do registro histórico do produto e liberação assinada da rotulagem (Arts. 40 e 87); amostragem com lógica estatística (Arts. 132 a 134) e registros de assistência técnica (Art. 129).

Regularização: o auditor confirma, a Anvisa decide

Classes III e IV passam por regularização com análise prévia, válida por 10 anos e com a CBPF como pré-requisito. Classes I e II seguem a via de notificação, que não expira nem exige CBPF, mas não dispensa as Boas Práticas. A empresa nacional precisa de AFE, e o fabricante estrangeiro é representado pelo importador. No MDSAP, você verifica se cada produto vendido no Brasil está regularizado.

CAPÍTULO 2 (CONTINUAÇÃO)

Brasil: Anvisa no MDSAP

Pela Lei 6.360/1976, Art. 13, uma alteração significativa precisa de nova aprovação antes de ser implementada. Exemplos: método de esterilização, local de fabricação, material, barreira estéril, validade, rotulagem ou nova versão de software. O que você procura é a análise regulatória de cada mudança e, quando exigido, o protocolo na Anvisa com data anterior à implementação.

Pós-mercado

SITUAÇÃO	PRAZO PARA NOTIFICAR
Óbito, ameaça à saúde pública ou falsificação	72 horas
Evento grave sem óbito; evento não grave que, se repetido, pode ser grave	10 dias
Queixa técnica que pode levar a evento grave	30 dias
Óbito, ameaça ou falsificação no exterior, com produto regularizado no Brasil	10 dias
Ação de campo, da decisão de iniciá-la (Anexo 3)	5 dias corridos

A tecnovigilância integra o SGQ: a alta direção designa o responsável por documento (Art. 5º), e, quando o fabricante é estrangeiro, o importador que o representa precisa ser mantido a par (Art. 8º). Para ações de campo, verifique o critério de decisão e o registro de todas elas, inclusive das que não foram notificadas. Nas reclamações, o Art. 121 pede unidade designada, avaliação de cada caso quanto à notificação, justificativa quando não se investiga, investigação imediata se houver óbito, lesão ou ameaça, e registro completo.

Projeto e escopo

No Brasil não há exceção ao controle de projeto: todas as classes o seguem. Na auditoria de projeto, a RDC 848/2024 serve de critério: as saídas mostram que os requisitos essenciais foram atendidos, e o que for considerado não aplicável precisa vir justificado. Atenção a uma referência: na p. 94 o P0002.011 cita o Art. 58 para a liberação do projeto, mas o texto da RDC 665 traz esse tema no Art. 59. Pelo Anexo 5, um escopo só de classes I e II pode ser desconsiderado para fins de CBPF; as Boas Práticas e a vigilância pós-mercado continuam valendo.

Fonte: MDSAP AU P0002.011, p. 26, 28, 35 a 41, 57, 58, 67, 72, 76, 83 a 94, 114, 118, 124, 154 e 161; Anvisa, legislação: RDC 665/2022, RDC 848/2024, RDC 67/2009, RDC 551/2021; Lei 6.360/1976. Vigência conferida em 22/09/2026.

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Brasil: Anvisa no MDSAP

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

Estados Unidos: FDA no MDSAP

NA AULA **Parte 1 • Bloco 3 • slides 28 a 41** **Caderno • E7, E8 e E9**

Observe em quais pontos a aula manda citar o CFR vigente em vez do texto reproduzido no P0002.011.

Desde 02/02/2026 a parte 820 do CFR incorpora a ISO 13485:2016 por referência. Para você, isso significa que o sistema da qualidade americano já está na ISO; o que é próprio dos Estados Unidos mora em outras partes do CFR.

A QMSR em poucas linhas

O 21 CFR 820 ficou com seis seções (820.1, 820.3, 820.7, 820.10, 820.35 e 820.45). A 820.7 incorpora a ISO 13485:2016 e a cláusula 3 da ISO 9000:2015; as demais tratam de definições, requisitos complementares, registros e rotulagem. A FDA deixou o QSIT e inspeciona pelo Compliance Program 7382.850, que não segue o plano MDSAP. O relatório MDSAP substitui a inspeção de rotina, mas não a inspeção "for cause" nem a de PMA.

PARTE DO CFR	ASSUNTO
807 e 814	Registro do estabelecimento, listagem, 510(k) e PMA
803	Relato de eventos adversos (MDR)
806	Correções e remoções
801 e 830	Rotulagem e UDI
821	Rastreamento de dispositivos com ordem da FDA

Autorização de mercado e mudanças

O owner or operator registra o estabelecimento e lista os dispositivos, com revisão anual entre 1º/10 e 31/12; o estrangeiro indica um agente nos EUA. A 510(k) é submetida ao menos 90 dias antes da venda, que só começa após a decisão de equivalência. Uma mudança que possa afetar de forma significativa a segurança ou a eficácia, ou alterar muito o uso, pede nova 510(k). Para classe III com PMA, a mudança que afeta segurança ou eficácia pede suplemento antes. Você procura a análise de cada mudança, não só a lista de números.

CAPÍTULO 3 (CONTINUAÇÃO)

Estados Unidos: FDA no MDSAP

Pós-mercado: três relógios diferentes

OBRIGAÇÃO	PRAZO
MDR de morte, lesão grave ou mau funcionamento reportável (803.50)	30 dias corridos
MDR quando há risco não razoável de dano substancial (803.53)	5 dias úteis
MDR suplementar com informação nova (803.56)	30 dias corridos
Correção ou remoção reportável (806.10)	10 dias úteis do início

O MDR vale para evento ocorrido dentro ou fora dos EUA com dispositivo vendido lá. A decisão de não reportar também deixa rastro: o arquivo de evento MDR guarda as deliberações (803.18). Na correção ou remoção não reportável, o 806.20 exige registro com identificação, lote e justificativa.

> **ONDE O P0002.011 FICOU PARA TRÁS**
>
> O Anexo 3 fala em 5 dias corridos; o 803.53 diz 5 dias úteis. A p. 60 ainda reproduz o antigo 820.198 sobre reclamações; valem a ISO 8.2.2 e o 820.35(a). As p. 114 e 115 trazem o texto anterior do 820.45 sobre rotulagem. Em todos os casos, você cita o CFR vigente.

UDI, rotulagem e cibersegurança

O UDI vem de agência credenciada pela FDA, com dados no GUDID, texto legível e AIDC; nova versão, novo modelo ou nova embalagem pedem novo DI (830.50). Para cibersegurança (seção 524B do FD&C Act) não existe tarefa exclusiva: você entra pelas Tarefas 5 e 12 do Capítulo 5 (entradas de projeto, plano de cibersegurança, atualizações e SBOM, modelagem de ameaças no risco) e pela Tarefa 12 do Capítulo 3 (relatos de vulnerabilidade como dado pós-mercado). O Summary of Changes aponta a Tarefa 7, mas o corpo do documento traz o tema nas Tarefas 5 e 12. A HSC consultou o CDRH por escrito, que confirmou o corpo do documento. É o método certo diante de uma contradição: consulta formal e resposta guardada como evidência.

Fonte: MDSAP AU P0002.011, p. 6, 10, 28, 37 a 44, 54, 57 a 64, 70 a 77, 81, 89 a 92, 97 a 100, 114 a 116, 124, 155 e 163; eCFR, 21 CFR 820, 803, 806, 807; FD&C Act 524B.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Estados Unidos: FDA no MDSAP

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

Canadá: Health Canada no MDSAP

NA AULA **Parte 2 • Bloco 4 • slides 3 a 14** **Caderno • E10, E11 e E12**

Observe a diferença entre o recall descrito no P0002.011 e a regra do CMDR em vigor desde 14/12/2024.

O Canadá é a jurisdição em que o certificado MDSAP tem efeito mais direto: sem ele, o fabricante não obtém licença para classes II a IV. Por isso o que você escreve no relatório pesa na permanência do produto no mercado.

Base legal e o limite do auditor

A Food and Drugs Act (F-27) sustenta o regulamento SOR/98-282, o CMDR. O MDSAP audita o sistema contra a ISO 13485 e a Parte 1 do CMDR. Pelo CMDR 32, classes II a IV exigem certificado de SGQ, e desde 01/01/2019 a Health Canada só aceita o emitido no MDSAP. Classe I não exige.

LIMITE DO AUDITOR

Você verifica se há evidência de segurança e eficácia. Declarar o dispositivo seguro e eficaz não é seu papel.

Licença, mudanças e obrigações anuais

O CMDR 26 proíbe importar ou vender dispositivo de classe II a IV sem licença, ou sem a licença emendada depois de uma mudança que a exija. O pedido é do fabricante, entendido como quem coloca o dispositivo no mercado com o próprio nome ou marca e assume a responsabilidade pelo projeto, pela fabricação ou pela rotulagem. Em private label, o que vai ao Canadá precisa estar licenciado e rotulado em nome do titular dessa licença.

OBRIGAÇÃO	BASE	PRAZO
Emenda de licença para mudança que a exija (significant change em III e IV; classe, nomes ou identificador em II a IV; indicação na II)	CMDR 34	Antes de vender
Declaração anual de mudanças não cobertas pelos arts. 34 e 43.1	CMDR 43	Antes de 1º de novembro
Aviso de venda encerrada no Canadá	CMDR 43(3)	30 dias
Cópia de certificado MDSAP novo ou alterado	CMDR 43.1	30 dias

CAPÍTULO 4 (CONTINUAÇÃO)

Canadá: Health Canada no MDSAP

Incidentes, riscos no exterior e síntese

Para o CMDR, incidente no Canadá envolve falha, deterioração ou rotulagem inadequada que causou morte ou deterioração grave da saúde, ou que poderia causá-las se voltasse a ocorrer. O relatório preliminar sai em 10 dias quando houve morte ou deterioração grave, e em 30 dias quando o risco está na recorrência. Incidente no exterior só se relata para classe I, e só quando há ação corretiva junto à agência local. Para II a IV, o caminho é outro: a Foreign Risk Notification (CMDR 61.2), em 72 horas, quando há em jurisdição da lista comunicação de risco grave, mudança de rotulagem, recall, reavaliação ou suspensão. Os relatórios de síntese (CMDR 61.4) têm periodicidade de 24 meses na classe II e de 12 meses nas classes III e IV, e ficam guardados com seus dados por 7 anos.

> **RECALL: CITE O CMDR VIGENTE**
>
> O P0002.011 descreve a regra anterior, com aviso inicial verbal ou escrito. Desde o SOR/2024-136, a informação vai por escrito em 24 horas da decisão (63.2), o conteúdo do art. 64 até o dia do início e o resultado em 30 dias após a conclusão (65). Procedimento que ainda aceita aviso verbal está desatualizado.

Rotulagem, distribuição e mudanças de 2026

O rótulo vem em inglês ou francês, nos dois idiomas se o produto for vendido ao público (CMDR 21 a 23). Os registros de distribuição precisam permitir retirada completa e rápida e são mantidos pela vida útil ou por 2 anos após o envio, o que for maior. Implantes do Schedule 2 exigem cartão de registro ou sistema aprovado. Fique atento: o SOR/2024-238 alterou o art. 36 a partir de 01/01/2026, e o SOR/2026-110, que traz novos procedimentos documentados, ainda não estava em vigor em 21/07/2026. O P0002.011 não reflete essas mudanças.

Fonte: MDSAP AU P0002.011, p. 30, 31, 36, 41, 42, 59, 67 a 69, 73, 74, 113, 116, 123, 149, 154 e 162; CMDR SOR/98-282, consolidação de 21/07/2026; SOR/2024-136; SOR/2024-238; SOR/2026-110.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Canadá: Health Canada no MDSAP

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

Austrália: TGA no MDSAP

NA AULA **Parte 2 • Bloco 5 • slides 15 a 26** Caderno • E13 e E14

Observe como a aula separa o que é do sponsor do que é do fabricante, e por que as mudanças vão à organização auditora.

Na Austrália quem detém a inclusão do dispositivo no ARTG é o sponsor, não o fabricante. Esse detalhe redesenha o escopo: parte das obrigações regulatórias australianas não é sua para auditar.

Marco legal e papel da organização auditora

O Therapeutic Goods Act 1989 define o sponsor e as condições de inclusão no ARTG, entre elas o acordo escrito com o fabricante. O TG(MD)R 2002 traz as Essential Principles no Schedule 1 e os procedimentos de avaliação de conformidade e de sistema da qualidade no Schedule 3. A organização auditora é reconhecida para avaliar o QMS em nome da TGA (Reg 3.5). É por isso que, para a Austrália, as mudanças são notificadas a ela.

SPONSOR

Detém a inclusão no ARTG

Importa, exporta ou fabrica na Austrália. Suas obrigações próprias ficam fora do escopo. Ele é ao menos cliente do fabricante e vira fornecedor se executa atividade terceirizada.

FABRICANTE

É quem você audita

Cumpre o Schedule 3 e as Essential Principles, atende ao que o sponsor exige por acordo e mantém a Declaração de Conformidade de cada produto.

Entre as obrigações do sponsor estão informar a TGA sobre eventos adversos, armazenar e transportar conforme o fabricante, manter registros de distribuição, fazer relatos anuais para as classes mais altas e conduzir o recall na Austrália. A lista completa está no Capítulo 7, Tarefa 5. A regra que resolve os casos: o requisito do sponsor só entra na auditoria quando o fabricante aceita a obrigação em acordo, e ela passa a valer como requisito de cliente.

Mudanças: à organização auditora, antes

Mudanças no QMS, no nome ou no local do fabricante, troca de fornecedor crítico, mudanças em processos críticos (esterilização, material de origem animal, substância medicinal) e, para classe III e IVD classe 4, mudanças de projeto, desempenho, usuário, embalagem ou armazenagem são notificadas à organização auditora antes da implementação. Ela escolhe se faz uma auditoria especial ou se verifica o tema na auditoria seguinte. A palavra que importa é "antes".

CAPÍTULO 5 (CONTINUAÇÃO)

Austrália: TGA no MDSAP

Eventos adversos e recall

Para evento ocorrido na Austrália com morte ou deterioração grave, real ou potencial, o fabricante avisa a TGA ou o sponsor "as soon as practicable". O mesmo vale para o recall, e o gatilho é a decisão de propor o recall, não o fim da investigação. O Anexo 3 não fixa número de dias; você verifica se o procedimento faz a comunicação sair logo que a empresa toma ciência do fato.

Essential Principles e documentação técnica

- **No projeto**: as EPs aplicáveis entram como entradas. Norma da Medical Device Standards Order aplicada por inteiro dá presunção de conformidade; sem ela, é preciso justificativa documentada.
- **No Anexo 1**: só a Austrália acrescenta revisão da documentação técnica contra as EPs, ampliando a amostragem da TGA, com conteúdo mínimo listado nas p. 147 e 148.
- **Na Declaração de Conformidade**: verificada por amostragem para dispositivos no ARTG.
- **Registros e UDI**: retenção mínima de 5 anos; o fabricante atribui o UDI e entrega dados corretos ao sponsor. A TGA implanta o UDI por classe: III e IIb desde 01/07/2026, IIa em 01/07/2027.

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Overview, p. 7; p. 24, 25, 28, 35, 39 a 41, 52, 53, 57, 58, 66, 72, 80 a 83, 88, 97, 98, 132 a 134, 147, 148 e 154; Therapeutic Goods Act 1989; TG(MD)R 2002, Schedules 1 e 3. Prazos de UDI: tga.gov.au, conferido em 22/09/2026.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Austrália: TGA no MDSAP

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

Japão: MHLW e PMDA no MDSAP

NA AULA **Parte 2 • Bloco 6 • slides 27 a 36** Caderno • E15 e E17

Observe quem fala com o regulador japonês e quem fala só com o MAH.

O fabricante brasileiro que você audita para o Japão costuma ser um Registered Manufacturing Site. Ele não se dirige ao regulador japonês: quem faz isso é o MAH. Identificar esse papel logo na abertura evita cobrar o que não é do auditado.

Marco legal e uso do MDSAP

O sistema da qualidade segue o MO169, a QMS Ordinance, cujo Capítulo 2 foi revisado em 2021 para acompanhar a ISO 13485:2016, com adequação até 25/03/2024. O PMD Act trata da licença do MAH, do registro de sites, das vias de autorização e das mudanças. O Japão participa do programa desde 2015 e, desde 04/2022, usa formalmente o relatório MDSAP no pedido do MAH, com menos documentos e inspeção remota no lugar da presencial.

REGISTERED MANUFACTURING SITE

Quem você visita

Faz projeto, montagem, esterilização ou armazenagem. Pede o próprio registro de site e comunica mudanças e eventos ao MAH.

MAH

Quem responde ao regulador

Residente no Japão e licenciado. Detém a autorização do produto, pede alterações à PMDA ou ao certificador e reporta eventos.

Vias de autorização

CLASSE	VIA	QUEM AVALIA
1	Notificação	PMDA recebe, sem QMS Certificate
2 e 3 com norma de certificação	Certificação	Registered Certification Body
2 e 3 sem norma, e 4	Aprovação	PMDA

Classe 1 é dispensada dos requisitos de projeto do MO169 (arts. 30 a 36-2). E como as Essential Principles já são verificadas antes da autorização, o Anexo 1 não pede revisão da documentação técnica contra elas para o Japão.

CAPÍTULO 6 (CONTINUAÇÃO)

Japão: MHLW e PMDA no MDSAP

Anexo 4 e o artigo 29

O Anexo 4 liga cada cláusula da ISO ao artigo correspondente do MO169 e registra as diferenças. Alguns exemplos: o site não precisa incluir comunicação às autoridades na análise crítica (art. 19); os itens 49.2 e 49.3 não se aplicam ao site (art. 49); e o site avalia e notifica eventos ao MAH, guardando registro (arts. 55-2 e 55-3).

O art. 29 é o que mais aparece na prática. Mudanças planejadas de projeto, material, esterilização, local ou validade são comunicadas ao MAH antes, e ele decide se pede alteração. A troca de local de esterilização ou de fabricação também vai ao MAH. Reclamações, retroalimentação e advisory notices pedem um arranjo de comunicação eficaz. Para verificar, peça o acordo firmado com o MAH, o procedimento de comunicação e os registros de cada envio.

Eventos adversos e retenção

O site informa o MAH "as soon as possible"; cabe ao MAH reportar ao regulador, nos prazos da regra japonesa. Vão ao MAH: mau funcionamento sério, no Japão ou no exterior; não sério e não previsto, no Japão; recall ou suspensão de venda de equivalente no exterior; e estudos que indiquem dano grave ou eficácia menor.

REGISTROS	RETENÇÃO MÍNIMA
Dispositivos de manutenção especialmente designada	15 anos, ou 1 ano mais a validade, se maior
Demais dispositivos	5 anos, ou 1 ano mais a validade, se a soma passar de 5
Treinamento	5 anos

Documento conta da obsolescência (art. 67); registro conta da criação (art. 68).

Fonte: MDSAP AU P0002.011, p. 6, 10, 28, 29, 36 a 38, 42, 53, 60, 69, 70, 74, 76, 91, 149 e 155 a 160 (Anexo 4); MHLW MO169; PMD Act; pmda.go.jp, conferido em 22/09/2026.

CAPÍTULO 6 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Japão: MHLW e PMDA no MDSAP

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 7

Cinco jurisdições, um evento

NA AULA **Parte 2 • Bloco 7 • slides 37 a 40** **Caderno • E16 e avaliação final**

Observe como um único fato aciona obrigações diferentes, com destinatários e prazos diferentes, em cada país.

Na auditoria real os países não chegam um de cada vez. A mesma reclamação ou a mesma mudança pode acionar cinco conjuntos de regras ao mesmo tempo. O papel do auditor líder é enxergar todos e cobrar cada um de quem tem a obrigação.

PAÍS	EVENTO GRAVE: A QUEM E QUANDO	MUDANÇA SIGNIFICATIVA: A QUEM
Austrália	Fabricante avisa TGA ou sponsor, assim que praticável	À organização auditora, antes (Reg 3.5)
Brasil	Anvisa: 72 h se houve óbito; demais casos em 10 ou 30 dias	Protocolo na Anvisa antes (Lei 6.360, Art. 13)
Canadá	Health Canada: 10 ou 30 dias; FRN, quando cabível, 72 h	Emenda de licença (CMDR 34)
Japão	Site informa o MAH assim que possível	Site informa o MAH (art. 29); o MAH pede à PMDA ou ao RCB
Estados Unidos	FDA: 30 dias corridos ou, em casos definidos, 5 dias úteis	Nova 510(k) ou suplemento de PMA antes

Como raciocinar diante de um evento

- **Onde ocorreu e onde o produto é vendido.** Algumas regras olham o local do evento; outras, o mercado do produto e a classe. Releia nos Capítulos 3 e 4 como Estados Unidos e Canadá tratam um evento ocorrido no exterior.
- **Quem é o destinatário.** Regulador, sponsor ou MAH. No Japão e, em parte, na Austrália, o fabricante cumpre a obrigação ao informar um intermediário.
- **Que tipo de relógio.** Horas, dias corridos, dias úteis ou "assim que praticável". Confira a contagem e o marco inicial: ciência, decisão ou início da ação.
- **Que outros efeitos o fato tem.** Um mesmo evento pode não ser incidente relatável e, ainda assim, gerar FRN ou entrar no relatório de síntese.

CAPÍTULO 7 (CONTINUAÇÃO)

Cinco jurisdições, um evento

Mudanças: quatro modelos

Anvisa e Health Canada aprovam a mudança antes da venda. A FDA libera ou aprova, conforme a via (510(k) ou PMA). Na Austrália, a organização auditora é notificada e decide como verificar. No Japão, o site informa o MAH, e é ele quem pede alteração à PMDA ou ao certificador. Em todos os casos, você procura a mesma coisa no auditado: a análise regulatória documentada e a evidência de que ela aconteceu antes da implementação.

REGRA DO MÓDULO

Se a norma em vigor diverge do P0002.011, cite a norma em vigor e registre a fonte que você consultou.

Divergências que você já conhece

- Canadá: recall pelo CMDR 63.2 vigente, não pela regra descrita no documento.
- Estados Unidos: 5 dias úteis no 803.53; reclamações pelo 820.35(a); rotulagem pelo 820.45 vigente.
- Estados Unidos: cibersegurança nas Tarefas 5 e 12, não na Tarefa 7 indicada no Summary of Changes.
- Brasil: liberação de projeto no Art. 59 da RDC 665, não no Art. 58.

PARA LEVAR AO MÓDULO 4

Guarde suas anotações dos estudos de caso deste módulo. O Módulo 4 parte desses achados para praticar graduação de não conformidade e redação do relatório.

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulos 2 e 4, Anexo 3 (p. 66 a 74, 154 e 155) e Summary of Changes (p. 163); CMDR 63.2; 21 CFR 803.53. Normas conferidas em 22/09/2026.

CAPÍTULO 7 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Cinco jurisdições, um evento

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 8

Glossário do módulo

Clause and Regulation

Campo da tarefa que lista a cláusula da ISO 13485:2016 e a referência de cada autoridade.

Additional country-specific requirements

Bloco da tarefa com o que cada país acrescenta à ISO. "None" indica que não há acréscimo.

Papel regulatório

Quem responde pela autorização de mercado em cada país. Define o que é auditável no fabricante.

Regularização

Ato da Anvisa que autoriza o produto no Brasil: notificação (classes I e II) ou análise prévia (classes III e IV).

QMSR

Quality Management System Regulation, o 21 CFR 820 vigente desde 02/02/2026, que incorpora a ISO 13485:2016 por referência.

MDR

Medical Device Reporting, relato de eventos adversos à FDA pelo 21 CFR 803.

Licença (Canadá)

Autorização exigida pelo CMDR para importar ou vender dispositivos de classe II a IV.

Foreign Risk Notification (FRN)

Aviso à Health Canada, em 72 h, de ação ou comunicação de risco grave no exterior (CMDR 61.2).

Sponsor

Quem detém a inclusão do dispositivo no ARTG. Suas obrigações próprias ficam fora do escopo da auditoria.

Essential Principles

Requisitos de segurança e desempenho do Schedule 1 do TG(MD)R 2002.

MAH

Marketing Authorization Holder: titular da autorização no Japão, residente e licenciado.

Registered Manufacturing Site

Local registrado que faz projeto, montagem, esterilização ou armazenagem para o Japão. Comunica-se com o MAH.

CAPÍTULO 9

Para revisar

Responda com as suas palavras, sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado. Os exercícios estão no Caderno.

1. Por que ler só o campo Clause and Regulation faz perder prazos? *(Cap. 1)*

2. Mudou o material de um produto vendido no Brasil: que evidência você pede? *(Cap. 2)*

3. Se a QMSR incorpora a ISO 13485, o que resta de específico dos EUA? *(Cap. 3)*

4. Como você trataria uma contradição entre duas partes do P0002.011? *(Caps. 3 e 7)*

5. No Canadá, o que o auditor conclui sobre segurança e eficácia, e por quê? *(Cap. 4)*

6. Quando uma obrigação do sponsor vira auditável no fabricante? *(Caps. 1 e 5)*

7. No Japão, por que o papel do auditado muda o que você cobra? *(Cap. 6)*

HSC | GLOBAL

MDSAP
MEDICAL DEVICE SINGLE AUDIT PROGRAM

EXEMPLAR GLOBAL
RTP CERTIFIED TRAINING

HSC Academy • MDSAP Lead Auditor, Excellence & Strategic Leadership

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

www.hscglobalgroup.com